РУССКИЙ

DIVA-5

Диагностический опросник по СДВГ у взрослых

Diagnostisch **I**nterview **V**oor **A**DHD bij volwassenen

Й. Й. С. Коой (PhD), М. Х. Франкен (MSc), Т. И. Брон (MSc), Д. Винчанк, MD, PhD

Март 2019, Фонд DIVA, Гаага, Нидерланды

DIVA Foundation

Диагностический опросник по СДВГ у взрослых

Выходные сведения

Диагностический опросник по СДВГ у взрослых – публикация Фонда DIVA, Гаага, август 2010.
Изменения в критерии DSM-5 внесли проф. Филип Эшерсон, др. Хосеп Антони Рамос-Квирога, др. Й. Й. Сандра Коой и Т. И. Аннет Брон, Фонд DIVA
prof. Philip Asherson, Instituut of Psychiatry, London
dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, Servicio de Psiquiatríal. CIBERSAM. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona
dr. J.J. Sandra Kooij en drs. T.I. Annet Bron, DIVA Foundation, 2016.
Заимствовано с разрешения издателя из Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.) (Диагностическое и Статистическое руководство по психическим расстройствам (5-я редакция), American Psychiatric Publishing, 2013.
Данная публикация составлена с надлежащей заботой. Однако по прошествии времени в публикацию местами могут быть внесены изменения. По этой причине к публикации не могут быть предъявлены правовые претензии. Более подробную информацию и изменения в будущем вы найдете на *www.divacenter.eu*.

Введение

DIVA-5 – третья редакция DIVA. Данная редакция содержит поправки, внесенные в DIVA -2.0 ввиду изменений в критериях диагностики гиперактивного расстройства/расстройства дефицита внимания (СДВГ). Согласно DSM-5, при диагностике СДВГ у взрослых речь идет об установлении наличия симптомов СДВГ как в детском, так и во взрослом возрасте.
Главные условия для диагноза – возникновение симптомов СДВГ в детстве и дальнейшее, пожизненное присутствие характерных признаков до момента нынешней эвалюации. Симптомы должны сочетаться с существенным клиническим нарушением психосоциальной деятельности по меньшей мере в двух жизненных сферах[1]. Поскольку СДВГ у взрослых – пожизненное расстройство, возникшее в детстве, необходимо установить симптомы, течение и уровень нарушений функционирования посредством, в частности, ретроспективного интервью о поведении в детстве. По возможности полученные от пациента сведения должны дополнить те, кто знал пациента ребенком (в большинстве случаев родители или близкие родственники)[2] .

Изменения в DSM-5 по сравнению с критериями DSM-IV-TR для СДВГ.

DSM-5 был опубликован в начале 2013 г., и для диагностики СДВГ у взрослых были внесены различные изменения. Ввиду этих изменений в DIVA внесены поправки. Краткий перечень поправок следует ниже:

- Начальный возраст. Критерий начального возраста в детстве, ранее "некоторые симптомы гиперактивности/импульсивности либо дефицита внимания, ведущие к ограничениям, присутствовали до 7-го года жизни", изменен на "различные симптомы дефицита внимания либо гиперактивности/импульсивности присутствовали до 12-го года жизни". В DSM-5 вызванные симптомами ограничения больше не являются условием до 12-го года жизни.
- Количество симптомов в детстве: общее число симптомов для диагностики в детстве не изменено (6/9 дефицита внимания и/или гиперактивности/импульсивности (HI). На протяжении по меньшей мере 6 месяцев должны были наблюдаться 6/9 симптомов, ограничивающих функционирование в одной или обеих областях, и различные симптомы должны были присутствовать до 12-го года жизни.
- Общее количество симптомов у взрослых: достаточное количество симптомов, требуемое для установления диагноза СДВГ у взрослых (с 17 лет) снижено с 6 до 5 симптомов как минимум в одной из симптомных областей: дефицита внимания и/или гиперактивности/импульсивности.
- Примеры: Учитывая примеры из DSM -5 были добавлены или дополнены некоторые примеры связанных с возрастом критериев. Это относится к критериям A1-A9, HI2, HI3, HI5, HI7 и HI9.
- Подтипы теперь называются "формами проявления", так как подтипы DSM в процессе развития оказались нестабильными. Формы проявления DSM-5 указывают на преобладающую симптомную область/симптомные области.

Эти изменения нашли отражение в DIVA-5.

Есть и другие – правда, не упомянутые в DIVA-5 – относящиеся к СДВГ поправки DSM -5:

1. СДВГ теперь категоризирован в главе "Нейробиологические расстройства развития", ранее "Расстройства, в большинстве случаев впервые диагностицируемые в грудном, детском или юношеском возрасте".
2. Новая возможность диагностики СДВГ и расстройства аутистического спектра у одного и того же пациента.
3. Также больше внимания уделено связанным с СДВГ признакам, подтверждающим диагноз, как-то: некоторая задержка речевого, двигательного либо социального развития; низкая терпимость к фрустрации, раздражительность, перепады настроения; когнитивные проблемы при проверке внимания, экзекутивных (исполнительных) функций или памяти.

Диагностический опросник СДВГ у взрослых (DIVA-5) основан на критериях DSM-5 и является третьей редакцией первого систематического нидерландского опросника по СДВГ у взрослых. DIVA-5 сменил DIVA-2.0, разработанный Й.Й.С. Кооой и М.Х. Франкен и основанный на критериях DSM-IV-TR2. DIVA 2.0 валидирован двумя исследованиями. [3,4]

Чтобы облегчить установление наличия/отсутствия всех 18 критериев СДВГ как в детстве, так и в зрелости, в опроснике даны конкретные, жизненные примеры поведения взрослых и детей. За основу взято характерное поведение, описанное взрослыми пациентами со СДВГ группе СДВГ у взрослых при PsyQ в Гааге. Также даны конкретные примеры нарушенного из-за симптомов функционирования в пяти областях: учеба и работа, любовные отношения и семейная жизнь, круг общения, свободное время/хобби; уверенность в себе/самооценка.
По возможности DIVA проводится со взрослым пациентом в присутствии партнера или родственников, чтобы таким образом одновременно составить суждение о ретроспективной и гетероанамнестической информации. На заполнение DIVA уходит от одного до полутора часов.

Вопросы DIVA касаются исключительно основных симптомов СДВГ, необходимых для диагностики согласно DSM-5, а не побочных психиатрических симптомов, синдромов или расстройств. Однако коморбидность часто наблюдается как у детей, так и у взрослых, примерно в 75% всех случаев. Поэтому важно провести общее психиатрическое исследование распространенных побочных симптомов, синдромов и расстройств. Наиболее распространенные расстройства при СДВГ – панические, депрессивные и биполярные расстройства, злоупотребление средствами и зависимость , нарушения сна и расстройства личности. Все эти расстройства должны быть изучены. Это необходимо для четкого представления о шкале симптомов, которые испытывает человек с СДВГ, а также для дифференциальной диагностики СДВГ во взрослом возрасте, позволяющей исключить прочие психиатрические расстройства как основную причину "симптомов СДВГ" у взрослых[2].

Инструкции к проведению DIVA

DIVA состоит из трех частей, каждая из которых применима как к детству, так и к зрелости.

- Критерии по дефициту внимания (A1)
- Критерии по гиперактивности/импульсивности
- Появление симптомов и вызванные ими нарушения функционирования

Начните с первого набора критериев DSM-5 по Дефициту внимания (A1), затем перейдите ко второму набору критериев по Гиперактивности/Импульсивности (A2). Задайте таким образом поочередно вопросы по всем 18 критериям. Руководствуйтесь по каждой теме следующим методом работы:
Сначала спрашивайте о зрелости (о наличии симптомов в последние шесть месяцев или дольше), затем о тех же симптомах в детстве (о симптомах с пяти до двенадцати лет)[5-7]. Зачитайте каждый критерий полностью и спросите, знакома ли проблема и может ли опрашиваемый привести пример. Пациенты часто приводят те же примеры, что и в DIVA, которые можно отметить галочкой. Если они не узнают симптомы или есть сомнение, подходит ли ответ к критерию, используйте приведенные примеры, все по порядку. Проблемное поведение или симптом засчитывается, если встречается чаще или в более тяжелой форме, нежели у схожей по возрасту и умственному развитию группы, либо сочетается с нарушением функционирования. Отметьте галочкой каждый узнанный либо описанный пациентом пример. Если по критерию приводятся другие подходящие примеры, укажите их как "прочие". Чтобы критерий был засчитан, не нужно, чтобы были узнаны все примеры – важно, чтобы у ведущего обследование создалось ясное представление о наличии либо отсутствии каждого из критериев.

По каждому критерию спрашивайте, подтверждают ли его партнер и родные или могут ли они привести другие примеры, подходящие к данному критерию. Обычно партнер дает отчет о взрослом возрасте, а родные (как правило, родители или старшие родственники) о детстве. Подводя итоги, ведущий/ая обследование руководствуется собственным клиническим суждением. Если ответы противоречивы, предпочтение по действующему принципу отдается информации, полученной от самого пациента[8].

Полученная от партнера и родных информация служит в основном дополнением к предоставленной пациентом и помогает составить наиболее точное представление о нынешнем поведении и поведении в детстве. Гетероанамнестическая информация родственников в основном имеет ценность для детства. Многим пациентам трудно вспомнить собственное поведение задним числом. Многие хорошо помнят период от десяти до двенадцати лет, но затрудняются припомнить ранний школьный возраст. Исследователь, основываясь на клинических суждениях, устанавливает по каждому критерию присутствие либо отсутствие его в обеих жизненных фазах, получив информацию от всех участников. Если невозможно получить гетероанамнез, диагноз ставится на основе анамнеза пациента. Если имеются в наличии табеля успеваемости, то с их помощью можно будет выявить симптомы, замеченные в детстве на уроках, и использовать их для подтверждения диагноза. Симптомы считаются клинически актуальными, если они были сильнее выражены либо проявлялись чаще, нежели у ровесников, или же приводили к нарушению функционирования.

Появление симптомов и вызванные ими нарушения функционирования

Третий раздел *Появления симптомов и вызванных ими нарушений* функционирования является важной частью диагностических критериев. Выясните, всегда ли у пациента были симптомы и если да, то наблюдались ли различные симптомы до двенадцати лет. Согласно определению DIVA-5 под "различными" подразумеваются по меньшей мере три симптома в одной из двух либо обеих областях до 12 лет. Если три симптома или более появились позднее, укажите момент их появления. Затем зачитывайте примеры по каждой области, в которой бывают нарушения функционирования, сначала во взрослом возрасте, потом в детстве. Отметьте крестиком узнаваемые примеры и укажите, имеют ли место нарушения функционирования в двух или более областях, как в детстве, так и в зрелости. Для установления диагноза нужно хотя бы умеренное нарушение функционирования по меньшей мере в двух ситуациях, как-то: работа/учеба, любовные отношения/семья, круг общения, свободное время/хобби и вера в себя/самооценка.

Изложение симптомов и формуляр подсчета

Укажите в Изложении симптомов дефицита внимания (A) и гиперактивности/импульсивности (HI), какие из 18 критериев присутствовали в детстве и в зрелости. Подсчитайте общее число симптомов в каждой из областей в детстве и в зрелости. Укажите в формуляре подсчета, присутствовали ли различные (согласно определению: 3 или более) симптомы A или HI до 12 лет. Укажите, присутствуют ли во взрослом возрасте (старше 17 лет) как минимум пять симптомов A либо HI. Укажите в каждой симптомной области, есть ли признаки пожизненного протекания симптомов, сочетаются ли симптомы с ограничениями, проявляются ли ограничения по меньшей мере в двух сферах и не объясняются ли они другим психиатрическим расстройством. Укажите, в какой степени гетероанамнез и школьные таблицы успеваемости подтверждают диагноз. Установите в заключение, можно ли поставить диагноз СДВГ и о каком подтипе (с кодом DSM-5) идет речь.

Предварительное пояснение для пациента

Данный опросник помогает выявить симптомы СДВГ, как в детстве, так и в зрелом возрасте. Вопросы основаны на официальных критериях СДВГ в DSM-5. По каждому критерию к Вам будет вопрос: знакома ли Вам данная проблема. Чтобы помочь Вам с опросником, я буду приводить наглядные примеры трудностей, которые симптомы СДВГ могут вызывать у взрослых и детей. Сначала вопросы будут к Вам, потом те же вопросы по возможности будут заданы партнеру и родственникам. Ваш партнер, наверное, узнал Вас уже взрослым/ой и сможет ответить на вопросы об этом периоде; родные, вероятно, лучше помнят Ваше поведение в детстве. Для диагностики СДВГ нужно иметь представление об обоих жизненных этапах.

.

Ссылки

1. American Psychiatric Association (APA): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013..
2. Diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0), in: Kooij JJS. ADHD
3. bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling. Pearson Assessment and Information, 3e druk, 2010. Доступно онлайн на различных языках *www.divacenter.eu*.
4. Pettersson R, Söderström S, Nilsson KW: Diagnosing ADHD in Adults: An Examination of the Discriminative Validity of Neuropsychological Tests and Diagnostic Assessment Instruments. J Atten Disord 2015; Dec 17:1-13.
5. Ramos-Quiroga JA, Nasillo V, Richarte V, Corrales M, Palma F, Ibáñez P, Michelsen M, Van de Glind G, Casas M, Kooij JJ: Criteria and Concurrent Validity of DIVA 2.0: A Semi-Structured Diagnostic Interview for Adult ADHD. J Atten Disord 2016; Apr 28:1-10.
6. Applegate B, Lahey BB, Hart EL, Biederman J, Hynd GW, Barkley RA, Ollendick T, Frick PJ, Greenhill L, McBurnett K, Newcorn JH, Kerdyk L, Garfinkel B, Waldman I, Shaffer D: Validity of the age-of-onset criterion for ADHD: a report from the DSM-IV field trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(9):1211-21.
7. Barkley RA, Biederman J: Toward a broader definition of the age-of-onset criterion forattention-deficit hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(9):1204-10.
8. Faraone SV, Biederman J, Spencer T, Mick E, Murray K, Petty C, Adamson JJ, Monuteaux MC: Diagnosing adult attention deficit hyperactivity disorder: are late onset and subthreshold diagnoses valid? Am J Psychiatry 2006; 163(10):1720-9.
9. Kooij JJS, Boonstra AM, Willemsen-Swinkels SHN, Bekker EM, De Noord I, Buitelaar JL: Reliability, validity, and utility of instruments for self-report and informant report regarding symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in adult patients. J Atten Disorders 2008; 11(4):445-458.

Заимствовано с разрешения издателя из Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.) (Диагностическое и Статистическое руководство по психическим расстройствам (5-я редакция), American Psychiatric Publishing, 2013.

Имя пациента

Дата рождения

Пол ❑ М / ❑ Ж

Дата заполнения

Обследование проводил(а)

Регистрационный номер пациента

Часть 1. Симптомы дефицита внимания (DSM-5, критерий A1)

Примите во внимание: симптомы в зрелости должны присутствовать хотя бы шесть месяцев. Симптомы в детстве относятся к возрасту от пяти до двенадцати лет. Приписать СДВГ можно только симптомы, имеющие хронический, а не эпизодический характер.

A1

Вы часто недостаточно внимательны к деталям или по небрежности допускаете ошибки в работе или других занятиях? *А как было в детстве (во время учебы в школе или других занятий)?*

Примеры (поведения) в зрелости

- ❑ Ошибки из-за небрежности
- ❑ Чтобы не делать ошибок, приходится замедлять темп работы
- ❑ Халатность, неряшливость в работе
- ❑ Невнимательное чтение инструкций
- ❑ Невнимание к деталям, упущения
- ❑ Неспособность выполнять детальные задания
- ❑ На детали уходит слишком много времени
- ❑ Буксуете, запутываетесь в деталях
- ❑ Ошибки и промахи из-за работы второпях
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры (поведения) в детстве

- ❑ Неряшливость, ошибки в школьных заданиях
- ❑ Ошибки из-за невнимательного чтения вопросов
- ❑ Невнимание к деталям, упущения
- ❑ Небрежное выполнение заданий
- ❑ Невнимательно прочитанные вопросы остаются без ответа
- ❑ Вопросы на обратной стороне листа во время контрольной остаются без ответа
- ❑ Замечания окружающих о небрежности в работе
- ❑ Не проверяете домашнюю работу
- ❑ На детальные задания уходит слишком много времени
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A2

Вам часто бывает трудно сосредоточиться на выполнении заданий? *А как было в детстве (во время игры)?*

Примеры в зрелости

- ❑ Неспособность долго сохранять внимание при выполнении заданий/исполнении обязанностей*
- ❑ Легко отвлекаетесь из-за размышлений и ассоциаций
- ❑ Легко отвлекаетесь из-за посторонних мыслей
- ❑ Трудно сохранять внимание при разговоре или чтении длинного текста
- ❑ Трудно досмотреть фильм или дочитать книгу*
- ❑ Все быстро приедается*
- ❑ Задаете вопросы по уже закрытой теме
- ❑ Прочее:

* За исключением особо интересных пациенту занятий (таких, как компьютер или хобби)

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Трудно сохранять внимание при выполнении школьного задания
- ❑ Трудно сохранять внимание во время игры*
- ❑ Трудно сосредоточиться во время урока, разговора, чтения длинного текста
- ❑ Легко отвлекается
- ❑ Трудно сосредоточиться*
- ❑ Нужен строгий график, чтобы не отвлекаться
- ❑ Занятия быстро приедаются*
- ❑ Прочее:

* За исключением особо интересных пациенту занятий (таких, как компьютер или хобби)

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A3

Обращаются к вам лично, а вы как будто не слышите? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Мечтательность, отсутствующий вид
- ❑ Трудно сосредоточиться на разговоре
- ❑ Неспособность вспомнить содержание разговора
- ❑ Частая перемена темы
- ❑ Окружающие говорят, что вы где-то витаете
- ❑ Отсутствующий вид, даже без явных отвлекающих факторов
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Не доходит, что говорят родители/учителя
- ❑ Мечтательность, отсутствующий вид
- ❑ Слушаете, только встретившись глазами или после повышении голоса
- ❑ Кажетесь отсутствующим даже без явных отвлекающих факторов
- ❑ Не слушаетесь с первого раза
- ❑ Приходится повторять вопросы
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A4

Вы часто не следуете указаниям, оставляете что-то недоделанным, не выполняете договоренностей на работе? *А как было в детстве (во время учебы в школе)?*

Примеры в зрелости

- ❑ Беретесь за несколько дел сразу и ни одного не доводите до конца
- ❑ Беретесь за дело, но быстро отвлекаетесь
- ❑ Необходим предельный срок, чтобы завершить работу
- ❑ Трудно довести до конца административную работу
- ❑ Трудно выполнять инструкции по эксплуатации
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Трудно выполнять инструкции
- ❑ Трудно выполнять задания из нескольких этапов
- ❑ Беретесь за что-то, но быстро отвлекаетесь
- ❑ Не доводите дело до конца
- ❑ Не доделываете или не сдаете домашнюю работу
- ❑ Нужен строгий распорядок, чтобы довести исполнение заданий до конца.
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A5

Вам трудно планировать работу и мероприятия? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Трудно планировать каждодневные занятия
- ❑ Трудно сделать несколько дел по порядку
- ❑ В доме и на рабочем месте беспорядок
- ❑ Трудно прибирать личные вещи и предметы, необходимые для работы
- ❑ Работа неряшлива и хаотична
- ❑ Чрезмерная либо неэффективная планировка
- ❑ Часто планируете встречи одновременно с уже назначенными
- ❑ Опаздываете
- ❑ Не укладываетесь в сроки
- ❑ Не умеете последовательно пользоваться ежедневником
- ❑ Не проявляете гибкости, настаивая на соблюдении расписания
- ❑ Плохое восприятие и распределение времени
- ❑ Составляете расписания, которыми потом не пользуетесь
- ❑ Не можете самостоятельно структурировать занятия
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Трудно уложиться в срок
- ❑ Беспорядок в комнате, на столе, в работе
- ❑ Трудно прибирать личные вещи и предметы, необходимые для работы
- ❑ Трудно играть в одиночестве
- ❑ Трудно планировать выполнение заданий или домашнюю работу
- ❑ Беретесь за несколько дел сразу
- ❑ Опаздываете
- ❑ Не укладываетесь в сроки
- ❑ Плохое восприятие времени
- ❑ Трудно себя развлечь
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A6

Вы часто отклоняете (терпеть не можете, неохотно исполняете) задания/обязанности, требующие длительного душевного напряжения? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Начинаете с самого легкого или приятного
- ❑ Часто откладываете выполнение скучных или трудных заданий
- ❑ Откладываете выполнение заданий и в результате пропускаете сроки
- ❑ Избегаете монотонной, в частности административной, работы
- ❑ Избегаете составления отчетов, заполнения бланков, просмотра длинных статей
- ❑ Не любите читать из-за умственной нагрузки
- ❑ Избегаете занятий, требующих серьезной концентрации
- ❑ Прочее

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Увиливаете от домашней работы или ее не любите
- ❑ Мало или неохотно читаете из-за умственной нагрузки
- ❑ Избегаете занятий, требующих серьезной концентрации
- ❑ Терпеть не можете школьные предметы, требующие серьезной концентрации
- ❑ Часто откладывает скучные или трудные задания
- ❑ Прочее

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A7

Вы часто теряете предметы, необходимые для заданий или занятий? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Теряете инструменты, бумаги, очки, сотовый телефон, бумажник, ключи или ежедневник
- ❑ Часто забываете где-то вещи
- ❑ Теряете рабочие документы
- ❑ Много времени тратите на поиски вещей
- ❑ Паникуете, когда другие что-то перекладывают, перемещают
- ❑ При уборке не кладете вещи на место
- ❑ Теряете списки, номера телефонов, записи
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Теряете школьные принадлежности, ручки, учебники и прочее
- ❑ Теряете одежду, игрушки или домашнее задание
- ❑ Тратите много времени на поиски вещей
- ❑ Паникуете, если другие не вернули что-то на привычное место
- ❑ Часто получаете замечания от родителей/учителей о потере вещей
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A8

Вы легко отвлекаетесь на внешние стимулы? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Трудно отключиться от внешних стимулов
- ❑ Отвлекшись, трудно вернуться к занятиям
- ❑ Легко отвлекаетесь из-за шума и (или) происходящего вокруг
- ❑ Прислушиваетесь к чужим разговорам
- ❑ Трудно фильтровать/отбирать информацию
- ❑ Прочее

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ В классе часто смотрите в окно
- ❑ Легко отвлекаетесь из-за шума или происходящего вокруг
- ❑ Отвлекшись, с трудом возвращаетесь к занятиям
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

A9

Вы часто забывчивы в повседневной жизни? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Забываете о встречах и других обязанностях
- ❑ Забываете ключи, ежедневник и пр.
- ❑ Окружающие вынуждены напоминать вам о договоренностях
- ❑ Забываете перезвонить или оплатить счета
- ❑ Приходится возвращаться домой за забытыми вещами
- ❑ Нужен строгий распорядок, чтобы ничего не забывать
- ❑ Забываете вести/проверять еженедельник
- ❑ Забываете о встречах, договоренностях
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Забываете уговор или задание
- ❑ Забываете выполнить поручение или сходить в магазин
- ❑ Приходится вам о многом напоминать
- ❑ Во время выполнения задания забываете, в чем оно заключается
- ❑ Забываете необходимые для занятий вещи в школу
- ❑ Забываете вещи в школе или у друзей
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Часть вторая: Симптомы гиперактивности/импульсивности (DSM-5, критерий A2)

Примите во внимание: симптомы в зрелости должны присутствовать по меньшей мере шесть месяцев. Симптомы в детстве относятся к возрасту от пяти до двенадцати лет. Приписывать СДВГ можно только симптомы, имеющие хронический, а не эпизодический характер.

H/I 1

Вы часто беспокойно двигаете руками или ногами или вертитесь, сидя на стуле? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Неусидчивы
- ❑ Болтаете ногами
- ❑ Постукиваете ручкой, вертите что-то в руках
- ❑ Грызете ногти или теребите волосы
- ❑ Умеете подавлять беспокойство, но это ведет к внутреннему напряжению
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Родители часто говорят: "Сиди тихо" и т. п.
- ❑ Болтаете ногами
- ❑ Постукиваете ручкой или вертите что-то в руках
- ❑ Грызете ногти или теребите волосы
- ❑ Не можете спокойно сидеть на стуле
- ❑ Умеете подавлять беспокойство, но это ведет к внутреннему напряжению
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 2

Вы часто встаете, когда требуется сидеть на месте? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Часто встаете с места в офисе или на другом рабочем месте
- ❑ Избегаете симпозиумы, лекции, церковные службы и пр.
- ❑ Предпочитаете хождение сидению
- ❑ Неусидчивость, постоянно в движении
- ❑ Усидчивость дается ценой напряжения
- ❑ Ищете повод встать и пройтись
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Во время еды и/или в классе часто встаете с места или отходите
- ❑ С большим трудом усиживаете за партой или за едой
- ❑ Часто велят сидеть на месте
- ❑ Выдумываете повод, чтобы встать и пройтись
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 3

Вы часто ощущаете беспокойство? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Внутренний дискомфорт, нервозность
- ❑ Постоянная потребность в действии
- ❑ Трудно расслабиться
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Беготня в неположенное время
- ❑ Залезаете на мебель или прыгаете на диване
- ❑ Лазаете по деревьям
- ❑ Внутренний дискомфорт, беспокойство
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 4

Вам трудно спокойно заниматься чем нибудь во время отдыха? *А как было в детстве (во время игры)?*

Примеры в зрелости

- ❑ Разговариваете там, где это неуместно
- ❑ В обществе постоянно привлекаете к себе внимание
- ❑ Ведете себя шумно в разного рода ситуациях
- ❑ Не можете чем-то заниматься спокойно
- ❑ Трудно говорить приглушенно
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Шумите во время игры / в классе
- ❑ Не можете спокойно смотреть телевизор / кино
- ❑ Просьбы успокоиться, не шуметь
- ❑ В обществе постоянно привлекаете к себе внимание
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 5

Вы часто не можете сидеть сложа руки или не можете остановиться вовремя? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Постоянная активность
- ❑ Трудно или некомфортно сидеть на месте, напр. в ресторане или на собрании
- ❑ Избыток энергии, неутомимость
- ❑ Вас считают беспокойным/ой или не поспевают за вами
- ❑ Переходите собственные границы
- ❑ Неумение отступиться, чрезмерная настойчивость
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Постоянная активность
- ❑ Вас считают беспокойным/ой или не поспевают за вами
- ❑ Трудно или некомфортно сидеть на месте
- ❑ Чрезвычайно деятельны в школе и дома
- ❑ Избыток энергии
- ❑ Неотступность, неумение остановиться
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 6

Вы часто говорите без умолку? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Утомляете людей разговорчивостью
- ❑ Считаетесь болтливым/ой
- ❑ Трудно замолчать
- ❑ Чрезмерная разговорчивость
- ❑ Не даете другим высказаться
- ❑ Многословны
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Считаетесь болтливым/ой
- ❑ Учителя и родители часто просят помолчать
- ❑ В дневнике записи о чрезмерной разговорчивости
- ❑ Наказание за болтовню
- ❑ Отвлекаете других от занятий болтовней
- ❑ Не даете другим высказаться
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 7

Вы часто отвечаете, не дожидаясь конца вопроса? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Что на уме, то и на языке
- ❑ Говорите, не подумав
- ❑ Отвечаете, не дав людям договорить
- ❑ Заканчиваете чужие фразы
- ❑ Бестактны
- ❑ Трудно в разговоре дождаться своей очереди
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Все выбалтываете, не подумав
- ❑ В школе опережаете других с ответом
- ❑ Брякаете, что в голову придет, даже если это неверно
- ❑ Перебиваете других на полуслове
- ❑ Кажетесь грубым /ой
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 8

Вы часто с трудом дожидаетесь своей очереди? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Не любите ждать, норовите пройти без очереди
- ❑ С трудом сохраняете спокойствие за рулем/в пробке
- ❑ Нетерпеливы
- ❑ Слишком поспешно заводите и разрываете личные и трудовые отношения
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ С трудом дожидаетесь своей очереди на тренировке/в игре
- ❑ С трудом дожидаетесь своей очереди в классе
- ❑ Все время хочется быть в центре внимания
- ❑ Нетерпеливы
- ❑ С трудом дожидаетесь своей очереди в разговоре
- ❑ Неосторожно переходите дорогу
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

H/I 9 Вы часто мешаете или навязываетесь другим? *А как было в детстве?*

Примеры в зрелости

- ❑ Назойливость, склонность к вмешательству
- ❑ Перебиваете других
- ❑ Без спроса вмешиваетесь в чужие занятия и берете их на себя
- ❑ Просят поменьше вмешиваться
- ❑ Трудно считаться с чужими границами
- ❑ Обо всем имеете суждение и прямо это высказываете
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Примеры в детстве

- ❑ Вмешиваетесь в чужие игры или занятия других
- ❑ Без спроса и без разрешения пользуетесь чужими вещами
- ❑ Влезаете в чужие разговоры
- ❑ На все реагируете
- ❑ Не умеете ждать
- ❑ Прочее:

Симптомы присутствуют? ❑ Да / ❑ Нет

Часть 3: нарушения функционирования вследствие симптомов (DSM-5, критерии B, C и D)

Критерий B

У вас всегда присутствовали упомянутые симптомы дефицита внимания и/или гиперактивности/импульсивности?

- ❑ Да (различные симптомы присутствовали еще до двенадцати лет)
- ❑ Нет
  (если нет, то в каком возрасте появились)

Критерий C

В каких областях у вас были трудности из-за вышеописанных симптомов?

Зрелость

Работа/Учеба

- ❑ Не завершили образования, необходимого для устройства на работу
- ❑ Работа/должность ниже уровня образования
- ❑ Новая работа быстро надоедает
- ❑ То и дело меняете работу
- ❑ Трудно вести администрацию, планировать
- ❑ Не повышают по работе
- ❑ Результаты ниже способностей
- ❑ Уход с работы из-за конфликта либо увольнение
- ❑ Отпуск по болезни вследствие жалоб
- ❑ Нарушение функционирования ограничено благодаря высокому IQ
- ❑ Нарушение функционирования ограничено благодаря структуре извне
- ❑ Прочее

Детство

(Семейные) отношения

- ❑ Отношения быстро приедаются
- ❑ Импульсивное начало/разрыв отношений
- ❑ Неравные отношения вследствие жалоб
- ❑ Сложности в отношениях, частые ссоры, недостаток тепла
- ❑ Развод вследствие жалоб
- ❑ Проблемы в сексуальной сфере вследствие жалоб
- ❑ Проблемы с воспитанием вследствие жалоб
- ❑ Трудно вести хозяйство/администрацию
- ❑ Финансовые затруднения/азартные игры
- ❑ Боязнь отношений
- ❑ Прочее:

Детство

- ❑ Уровень образования ниже IQ
- ❑ Оставляют на второй год из-за проблем с концентрацией
- ❑ Бросаете школу/выгоняют из школы
- ❑ Период учебы намного дольше обычного
- ❑ Образование в соответствии с IQ удалось завершить с большим трудом
- ❑ Трудно делать уроки
- ❑ Приходится перейти в специальное училище из-за жалоб
- ❑ Замечания учителей о поведении/концентрации
- ❑ Нарушение функционирования ограничено благодаря высокому IQ
- ❑ Нарушение функционирования ограничено благодаря структуре извне
- ❑ Прочее:

Семья

- ❑ Частые ссоры с братьями/сестрами
- ❑ Частые наказания/побои
- ❑ Редкое общение с родными из-за конфликтов
- ❑ Дольше обычного нужен родительский надзор
- ❑ Прочее:

Зрелость *(продолжение)*

Круг общения

- ❑ Знакомства быстро надоедают
- ❑ Трудно поддерживать общение
- ❑ Конфликты вследствие коммуникативных проблем
- ❑ Трудно заводить знакомства
- ❑ Приниженность вследствие неудач
- ❑ Невнимательность (забываете написать, посочувствовать, позвонить и пр.)
- ❑ Прочее:

Свободное время /хобби

- ❑ Неспособность расслабиться на отдыхе
- ❑ Можете расслабиться только после интенсивных занятий спортом
- ❑ Травмы вследствие интенсивных занятий спортом
- ❑ Не в состоянии дочитать книгу или досмотреть фильм
- ❑ Переутомление из-за постоянной активности
- ❑ Хобби быстро приедаются
- ❑ Аварии/лишение водительских прав из-за бесшабашного вождения
- ❑ Жажда сильных ощущений/рискованные поступки
- ❑ Соприкосновение с полицией/судебными органами
- ❑ Приступообразное переедание
- ❑ Прочее:

Вера в себя/самооценка

- ❑ Неуверенность в себе из-за критики окружающих
- ❑ Низкая самооценка из-за неудач
- ❑ Боязнь провала мешает новым начинаниям
- ❑ Болезненная реакция на критику
- ❑ Перфекционизм
- ❑ Переживания из-за симптомов СДВГ
- ❑ Прочее:

Детство *(продолжение)*

Круг общения

- ❑ Трудно поддерживать общение
- ❑ Конфликты из-за коммуникативных проблем
- ❑ Трудно заводить знакомства
- ❑ Приниженность вследствие неудачного опыта в общении
- ❑ Мало друзей/подружек
- ❑ Вас дразнили, обижали
- ❑ Вас отвергают, не принимают в группу
- ❑ Дразните, обижаете других
- ❑ Прочее:

Свободное время /хобби

- ❑ Неумение расслабиться на отдыхе
- ❑ Чтобы расслабиться, нужно много заниматься спортом
- ❑ Травмы вследствие чрезмерного увлечения спортом
- ❑ Не в состоянии дочитать книгу или досмотреть фильм
- ❑ Переутомление из-за постоянной активности
- ❑ Хобби быстро приедаются
- ❑ Жажда сильных ощущений/рискованные поступки
- ❑ Соприкосновение с полицией/судебными органами
- ❑ Частые несчастные случаи
- ❑ Прочее:

Вера в себя/самооценка

- ❑ Неуверенность в себе из-за отрицательных суждений других
- ❑ Низкая самооценка из-за неудач
- ❑ Боязнь провала мешает предпринять что-то новое
- ❑ Болезненная реакция на критику
- ❑ Перфекционизм
- ❑ Прочее:

Зрелость: имеют ли место нарушения функционирования по меньшей мере в двух областях?	❑ Да / ❑ Нет
Детство: имеют ли место нарушения функционирования по меньшей мере в двух областях?	❑ Да / ❑ Нет

Конец опросника. Перейдите к обобщению.

Особенности можно указать здесь:

Обобщение симптомов Дефицита внимания (A) и Гиперактивности/импульсивности (HI)

Укажите и подсчитайте критерии, засчитанные в частях 1 и 2

Критерий DSM-5	Симптом	Присутствует в зрелости	Присутствует в детстве
A1a	A1. Часто не удается уделить достаточное внимание деталям либо по небрежности допускаются ошибки в школьных заданиях, работе и прочей деятельности		
A1b	A2. Часто трудно сосредоточиться во время исполнения заданий/обязанностей или игры.		
A1c	A3. Как будто не слышит прямого обращения		
A1d	A4. Часто не следует инструкциям и оставляет уроки и дела недоделанными, либо не выполняет договоренностей на работе		
A1e	A5. Часто трудно дается организация занятий и мероприятий		
A1f	A6. Часто отклоняет (терпеть не может, неохотно исполняет) задания/обязанности, требующие длительного душевного напряжения		
A1g	A7. Часто теряет предметы, необходимые для заданий или занятий		
A1h	A8. Часто легко отвлекается на внешние стимулы		
A1i	A9. Часто забывчив(а) во время каждодневных занятий		
Общее число критериев Дефицита внимания		☐ / 9	☐ / 9
A2a	H/I 1. Часто беспокойно шевелит руками и ногами, вертится, сидя на стуле		
A2b	H/I 2. Часто встает в классе или других ситуациях, где полагается сидеть на месте		
A2c	H/I 3. Часто бегает или залезает на что ни попадя там, где это неуместно (у молодежи или взрослых это может ограничиваться внутренним дискомфортом)		
A2d	H/I 4. Трудно спокойно играть или отдыхать		
A2e	H/I 5. Постоянная деятельность, неумение остановиться		
A2f	H/I 6. Часто говорит без умолку		
A2g	H/I 7. Часто отвечает, не дослушав вопроса		
A2h	H/I 8. Часто с трудом дожидается своей очереди		
A2i	H/I 9. Назойлив(а), мешает окружающим		
Общее число критериев Гиперактивности/Импульсивности		☐ / 9	☐ / 9

Формуляр подсчета

DSM-5 критерий A	**Детство** Присутствуют ли различные (3 или более) симптомы Д или ГИ? **Зрелость** Число признаков Д ≥ 5? Число признаков ГИ ≥ 5?	❑ Да / ❑ Нет ❑ Да / ❑ Нет ❑ Да / ❑ Нет
DSM-5 критерий B	Есть указания на пожизненное присутствие симптомов, возникших до 12-летнего возраста?	❑ Да / ❑ Нет
DSM-5 критерии C и D	Симптомы и ограничения проявляются по меньшей мере в 2 жизненных сферах? Зрелость Детство	❑ Да / ❑ Нет ❑ Да / ❑ Нет
DSM-5 критерий E	Можно ли приписать симптомы другому психическому расстройству?	❑ Нет ❑ JДа, а именно:
	Подтверждается ли диагноз гетероанамнезом? Родители/брат/сестра/пр., а именно _____ * Партнер/друзья/пр., а именно _____ * Школьные дневники 0 = нет / незначительно 1 = в какой-то мере 2 = явно подтверждается	 ❑ н.и.р ❑ 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ н.и.р ❑ 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ н.и.р ❑ 0 ❑ 1 ❑ 2 Пояснение:
	Диагноз СДВГ**	❑ Нет Да: ❑ 314.01 Комбинированная форма проявления ❑ 314.00 Преимущественно невнимательная форма проявления ❑ 314.01 Преимущественно гиперактивно-импульсивная форма проявления ❑ 314.01 Другое определенное расстройство дефицита внимания/гиперактивности ❑ 314.01 Неопределенное расстройство дефицита внимания/гиперактивности ❑ Частично в ремиссии
	Форма	❑ легкая ❑ умеренная ❑ тяжелая

* Укажите, с кем был проведен гетероанамнез.

** Если формы проявления в детстве и зрелости различны, при диагнозе превалируют нынешние, взрослые формы проявления.

РУССКИЙ

DIVA-5

DIVA Foundation

Диагностический опросник по СДВГ у взрослых